REVISION DE CASO

Expositores: Anderson García – Rafael Giraldo

Ginecóloga a Cargo: Dra Sharon Acuña

Ginecología

Moniquirá 17/02/2026

Paciente de 31 años de edad.

C.L

Antecedentes:

- Cuadro de ansiedad – labilidad emocional
- Tóxicos - Alérgicos: **Fumadora ocasional de ¾ cigarros al día.**
- Familiares:

Hipertensión arterial, Cardiopatía – Madre

- Cáncer de seno – Hermana
- Cáncer de endometrio hermana
- Cáncer de pulmón - Papá
- Cáncer de piel - Tía

PROCEDENCIA: HUILA

VIVE: BARBOSA SANTANDER

OCUPACIÓN: AUX-. ADMINISTRATIVA

HIJOS: 1

CONSULTA POR MEDICINA GENERAL
06-06-2025

Modalidad de Atención Intramural HRM

MOTIVO DE CONSULTA

" ASTENIA, ADINAMIA, HIPOREXIA "

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE ASISTE A CONSULTA POR CUADRO DE CEFAELA HOLOCRANEANA, CON SENSACION DE PARESTESIAS EN HEMICARA DERECHA, HIPOREXIA, ASTENIA, ADINAMIA. REFIERE ADEMAS EPIGASTRALGIA, ARDOR, DISNTENSION ABDOMINAL.

ANALISIS

PACIENTE ASISTE A CONSULTA POR CUADRO DE CEFAELA HOLOCRANEANA, CON SENSACION DE PARESTESIAS EN HEMICARA DERECHA, HIPOREXIA, ASTENIA, ADINAMIA. REFIERE ADEMAS EPIGASTRALGIA, ARDOR, DISNTENSION ABDOMINAL. PACIENTE CON SIGNOS VITALES NORMALES, SIN SIGNOS DE FOCALIZACION NEUROLOGICA, PARACLINICOS CON LDL LEVEMENTE ELEVDA, RESTO DE PARACLINICOS NORMALES, SE INCENTIVAN HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DADO LA PERSISTENCIA DE LOS SINTOMAS Y LA PRESENCIA DE SINTOMAS DISPEPTICOS, SE SS VAL POR EL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR.

PLAN:

SUCRALFATO 10 CM CADA 12 HORAS
SE SS VAL POR EL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR.
SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA.



PRIMERA CONSULTA CON MEDICINA FAMILIAR 03-08-2025

ENFERMEDAD ACTUAL

PACIENTE FEMENINA DE 30 AÑOS DE EDAD, QUIEN CONSULTA POR CUADRO CLINICO DESDE 4 AÑOS DE EVOLUCION DE CEFALEA HOLOCRANEANA ASOCIADO A FOTOFOBIA, NO EN ESTUDIO POR NINGUNA ESPECIALIDAD REFIERE MANEJO EN CASA CON AINES, CON IRRRADIACION A REGION CERVICAL POSTERIOR , NAUSEAS Y MAREOS OCASIONALES, REFIERE EPIGASTRALGIA OCASIONAL SIN TRATAMIENTO ESPECIFICO. PACIENTE CON HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL, CICLOS MENSTRUALES IRREGULARES SECUNDRIO A IMPLANTE SUBDERMICO, PERDIDA DE DESEO SEXUAL HACE MAS DE UN AÑO QUE DIFICULTAD SU RELACION DE PAREJA, CUADRO DE ANSIEDAD CON LABILIDAD EMOCIONAL, CAMBIOS EN EL ESTADO DE ANIMO POR CARGAR LABORAL Y FALTA DE RED DE APOYO FAMILIAR, CON IDEACION SUICIDAD EN ALGUNAS OCASIONES

ANTECEDENTES:
PATOLOGICOS:
CUADRO DE ANSIEDAD Y LABILIDAD EMOCIONAL?
GASTRITIS ?
FARMACOLOGICOS: ADVIL FUERTE, CITRATO DE MAGNESIO, GAVISCON
TOXICO- ALERGICOS: FUMADORA OCASIONAL 3/4 CIGARROS AL DIA
FAMILIARES:
HIPERTENSION ARTERIAL - CARDIOPATIA - MADRE
CANCER DE SENO- HERMANA
CANCER DE ENDOMETRIO - HERMANA
CANCER DE PULMON - PAPA
CANCER DE PIEL - TIA

- ALTERACION EN EL ESTADO DE ANIMO --> QUE CONDICIONAN LA APARICION DE SINTOMATOLOGIA.
- MEDICACION: TRAZADONA
- APOYO CON PSIQUIATRIA
- SE RENUEVA ESTUDIOS DE GINECOLOGIA --> PARA DESCARTAR CAUSAS DE HUA

- PRUEBA DE ALIENTO H.PYLORI
- TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE
- ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL
- CCVU

ECOGRAFÍA: TRANSVAGINAL 18-08-2025

ULTRASONOGRAFÍA PÉLVICA TRANSVAGINAL

Examen ultrasonográfico realizado con transductor transvaginal de multifrecuencia con técnica de alta definición.

Útero en AVF, de contornos regulares y ecoestructura homogénea que mide 67x63x49 mm. Con volumen de 111 cc. miometrio irregular por presencia de MIOMA FIGO 6 en caranaterior de 19x17 mm

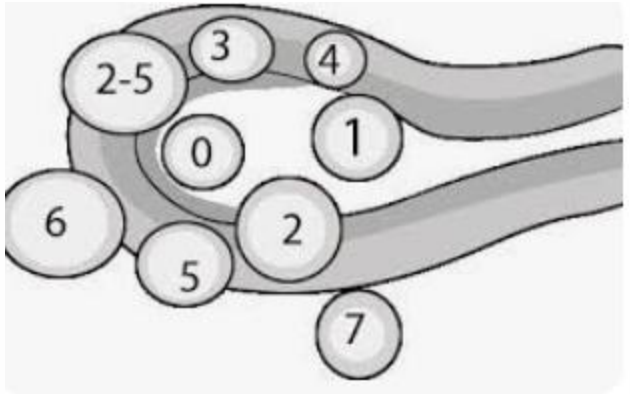
Endometrio regular homogéneo de 6.5 mm, cavidad vacía

Ovario derecho de 24x14x22 mm. Con volumen de 4.2 cc. Aspecto ecográfico normal
Ovario izquierdo reenpalazado por imagen unilocular de bordes regulares de 36x29x33 mm. Con volumen de 18 cc. con escasa capotación Doppler color.

Cuello: de aspecto ecográfico normal.

Fondos de saco libres.

OPINIÓN:
QUISTE SIMPLE EN ANEXO IZQUIERDO.
MIOMA UTERINO.



- QUISTE EN ANEXO IZQUIERDO
- MIOMA UTERINO

PRIMERA CITA GINECOLOGÍA
14-10-2025

Modalidad de Atención
MOTIVO DE CONSULTA
CICLO MENSTRUAL IRREGULAR,
ENFERMEDAD ACTUAL
PACIENTE CON PLANIFICACION CON JADELLE, REFIERE CICLOS MNESTRUALES IRREGULARES, CON SANGRADO INTERMENSTRUAL, PERSISTENTE Y DISMINUCION DE LA LIBIDO, PACINETE ADEMAS APORTA ECOGRAFIA REALIZADA EN ESTA ISTITUCION EL 18/08/2025: Estructura homogénea que mide 67x63x49 mm. Con volumen de 111 cc. miometrio irregular por presencia de MIOMA FIGO 6 en caranaterior de 19x17 mmEndometrio regular homogéneo de 6.5 mm, cavidad vacía Ovario derecho de 24x14x22 mm. Con volumen de 4.2 cc. Aspecto ecográfico normal Ovario izquierdo reenpalazado por imagen unilocular de bordes regulares de 36x29x33 mm. Con volumen de 18 cc. con escasa capotación Doppler color, sin otro hallazgos, sin otro halalzgo, niega fiebre, emesis.

- TAMAÑO DE TUMORACION EN LIMITE QUIRURGICO
- PACIENTE NO DESEA OBSERVACION DADO ANTECEDENTE DE CA EN LA FAMILA
- SE PROGRAMA PARA LAPAROSCOPIA --> RESECCION DE TUMOR DE OVARIO IZQUIERDO

INGRESO A QUIROFANO: 05/02/2026

**********INGRESO SALAS DE CIRUGIA**********
PACIENTE INGRESA PROGRAMADO PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

ENFERMEDAD ACTUAL
PACIENTE DE 31 AÑOS DE EDAD, QUIEN ASISTE A LA INSTITUCIÓN PROGRAMADA PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO RESECCION DE TUMOR DE OVARIO IZQUEIRDO EL DÍA DE HOY EN HORAS DE LA TARDE. PACIENTE ASINTOMÁTICA115/. NIEGA SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES, PICOS FEBRILES U OTRA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA. AYUNO COMPLETO.

EXAMEN FÍSICO:
PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, HIDRATADA/O, AFEBRIL, SIN DIFICULTAD RESPIRATORIA.
TA: 115/79 MMHG FC: 70 LPM FR: 17 RPM SATO2: 99 %
CABEZA Y CUELLO: ESCLERAS Y CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN ADENOPATÍAS NI INGURGITACIÓN.
TÓRAX: SIMÉTRICO, NORMOEXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR CONSERVADO SIN AGREGADOS, RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS.
ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN, SIN MASAS O VISCEROMEGALIAS, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL.
EXTREMIDADES: MÓVILES, SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, LLENADO CAPILAR MENOR A DOS SEGUNDOS.
NEUROLÓGICO: ALERTA, ADECUADA INTERACCIÓN CON EXAMINADOR, GLASGOW 15/15, SIN DÉFICIT SENSITIVO O MOTOR APARENTE.

ANÁLISIS:
PACIENTE EN PLAN DE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, RESECCION DE TUMOR DE OVARIO IZQEUIRDO , PARA EL DÍA DE HOY EN HORAS DE LA MAÑANA. ASINTOMÁTICA/O, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, CON SIGNOS VITALES EN RANGO DE NORMALIDAD. AYUNO COMPLETO. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO, RIESGOS BENEFICIOS Y POSIBLES COMPLICACIONES, SE INDAGAN Y SE RESUELVEN DUDAS, PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ESTAR DE ACUERDO SE FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SE INDICA PASO A SALAS DE CIRUGÍA.

- PACIENTE INGRESA EN BUENAS CONDICIONES
- INFORMADA DEL PROCEDIMIENTO EN CUANTO A BENEFICIOS, Y RIESGO DE COMPLICACIONES.
- PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

INFORME QUIRÚRGICO GINECOLOGÍA 05-02-2026

Descripcion de Hallazgos Operatorios, Procedimientos y Complicaciones

UTERO DE ASPECTO MACRO NORMAL CON ADHERENCIA DENSA DE FONDO UTERINO DENSA A PARED ABDOMINAL, CON RESTRACCION DE REPLIEGUE VESICO VAGINAL HACIA ADELANTE. QUISTE DE OVARIO IZQUIERDO CONTENIDO LIQUIDO TRANSPARENTE APROX 3 CM CON ADHERENCIA A LA TROMPA. TORMPA DERECHA DE ASPECTO MACRO NORMAL. OVARIO ODERECHO DE ASPECTO MACRO NORMAL. FONDOS DE SACO LIBRES. HIGADO, ESTOMAGO, EPIPLON MESENTERIO INTESTINO SIN IMPLANTES SOSPECHOSOS. PERITONEO LIBRE, NO SE VISUALIZAN LESIONES ADVERTIDAS SOBRE NINGUNA ESTRUCTURA ABDOMINAL.

SE REALIZA USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN EL CONTEXTO DE COVID-19. SE CONFIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO PREVIO POR PARTE DE LA PACIENTE.
PACIENTE COLOCADA EN DECÚBITO DORSAL. POSTERIORMENTE, SE LLEVA A CABO PROCESO DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE CAMPO QUIRÚRGICO, SE REALIZA CATETERISMO VESICAL Y SE COLOCAN CAMPOS ESTÉRILES.SE EFECTÚA INFILTRACIÓN CON ANESTÉSICO LOCAL A NIVEL UMBILICAL. SE PROCEDE AL

INGRESO A LA CAVIDAD ABDOMINAL MEDIANTE LA TECNICA DE VERESS, LOGRANDO CREAR NEUMOPERITONEO CONTROLADO, COLOCACION DE TROCAR DE 10 MM, POSTERIORMENTE CAMARA CON LENTE DE 30° VISUALIZACION DE ENTRADA SIN EVIDENCIA DE LESIONES ADVERTIDAS.

INSUFLACION CO2 HASTA 15 MM HG. REVISION DE ENTRADA SIN LESIONES. REVISION SISTEMATICA DE LA CAVIDAD. BAJO VISION DIRECTA INSERCION DE TROCARES AUXILIARES DE 5 MM EN FLANCO Y FOSA ILIACA IZQUIERDA. SE REALIZA RESECCION DE TUMOR DE OVARIO, SE REALIZA DISECCION POR TECNIA DE TRACCION CONTRATRACCION DE CAPSULA DE TUMOR, SE VERIFICA HEMOSTSIA, EXTRACCION DE PIEZA QUIRURGICA EN BOLSA RECUPERADORA Y DRENAJE DE QUISTE DENTRO DE LA BOLSA EVITANDO DERRAME INTRACAVITARIO, SE REALIZA LIBERACION DE ADHRENEIAS DENSAS DE UTERO A ARED ABDOMINAL CON ENERGIA BIPOLAR AVANZADA, RETIRO DE INSTRUMENTOS Y REDUCCION COMPLETA DE CO2. CIERRE DE APONEUROSIS UMBILICAL CON VICRYL 0. PIEL PROLENE 3-0.



1. COLOCACIÓN DE TROCAR
2. CAMARA --> NO SE VISUALIZAN LESIONES
3. VISUALIZACION DIRECTA TROCARES AUXILIARES IZQUIERDOS.
4. RESECCION DE TUMOR
5. EXTRACCION EN BOLSA RECUPERADORA
6. RETIRO INSTRUMENTOS

06/02/2026

INGRESO URGENCIAS GINECOOBSTETRICIA 08+16 AM

MOTIVO DE LA CONSULTA:

"TENGO MUCHO ARDOR EN LA BOCA DEL ESTOMAGO"

ENFERMEDA ACTUAL:

PACIENTE DE 31 AÑOS EN POP DIA 1 DE RESECCION DE QUISE OVARICO IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA, REFIERE DESDE EL EGRESO AYER DOLO EN HIPOGASTRIO LEVE, HACE APROXIAMDAMMENTE 6 HORAS PRESENTA EPIGASTRALGIA TIPO ARDOR 10/10 DE INTENSIDAD, PACIENTE ALGIDA, NIEGA EPISODIOS EMETICOS, DIURESIS DE CARACTERISTICAS NORMALES, NIEGA DEPOSICIONES, NIEGA PICOS FEBRILES U OTROS SINTOMAS.

ANTECEDENTES:
PATOLOGICOS NIEGA
ALERGIAS NIEGA
QUIRURGICOS RESECCION DE QUISE OVARICO IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA, CESAREA
G/O M 12 AÑOS G1C1V1- PLANIFICA CON JADELLE- FUR 04/02/2026

ANALISIS

PACIENTE DE 31 AÑOS EN POP DIA 1 DE RESECCION DE QUISE OVARICO IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA, REFIERE DESDE EL EGRESO AYER DOLO EN HIPOGASTRIO LEVE, HACE APROXIAMDAMMENTE 6 HORAS PRESENTA EPIGASTRALGIA TIPO ARDOR 10/10 DE INTENSIDAD, PACIENTE ALGIDA, NIEGA EPISODIOS EMETICOS, DIURESIS DE CARACTERISTICAS NORMALES, NIEGA DEPOSICIONES, NIEGA PICOS FEBRILES U OTROS SINTOMAS. EN EL MOMENTO HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, ALERTA, AFEBRIL, HDIRATADA, NORMOTENSA, AL EXAMEN FISICO DOLOR EN HEMIABDOMEN SUPERIOR, DEFENSA VOLUNTARIA, HERIDAS QUIRURGICAS DE LAPAROSCOPIA EN BUENAS CONDICIONES, ABDOMEN BLANDO EN HIPOGSTRIO SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL EN EL MOMENTO, AL TACTO VAGINAL SIN CAMBIOS CERVICALES SANGRADO ESCASO QUE ASOCIA A SU MENSTRUACION, PACIENTE ALGIDA, SE INDICA NADA VIA ORAL, ACCESO VENOSO AHORA CON ANALGESIA EV, SS PARACLINICOS, SE DEFINIRAN OTRAS CONDUCTAS CON REPORTES SEGUN EVOLUCION, PACIENTE Y FAMILIAR MANIFIESTAN ENTENDER Y ACEPTAR.

IDX:
POP DIA 1 DE RESECCION DE QUISE OVARICO IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA
DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO
DISPEPSIA

ESTADO GENERAL: PACIENTE EN BUEN ESTADO GENERAL INGRESA CAMINANDO POR SUS PROPIOS MEDIOS
CABEZA Y CUELLO: CONJUNTIVA NORMOCRÓMICA ESCLERA ANICTÉRICA MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL SIN MASAS SIN ADENOPATÍAS , MUCOSA ORAL HÚMEDA-
CARDIOPULMONAR: RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO SOPLOS, RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS, NO PRESENTA SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, DOLOROSO A LA PALPACION EN HEMIABDOMEN SUPERIOR, DEFENSA INVOLUNTARIA, LEVE DOLOR EN HIPOGASTRIO, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, HERIDAS QURURGICAS EN BUENAS CONDICIONES
GENITOURINARIO: GENITALES FEMENINOS NORMOCONFIGURADOS VAGINA NORMOTENSA NORMO ELÁSTICA, CUELLO POSTERIOR, LARGO, CERRADO, SANGRADO VAGINAL ESCASO
EXTREMIDADES: MÓVILES SIMÉTRICAS ADECUADA PERFUSIÓN DISTAL NO SE EVIDENCIAN EDEMAS
NEUROLÓGICO: PACIENTE CONSCIENTE ALERTA ORIENTADA FUERZA Y SENSIBILIDAD CONSERVADAS, NO DÉFICIT MOTOR NI SENSITIVO APARENTE

- DESDE SU #1 DÍA POP REFIERE DOLOR EPIGASTRICO LEVE, DOLOR A LA PALPACIÓN, PERO SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL INICIALMENTE.
- NO SE ENCUENTRAN SIGNOS DE INFECCIÓN DE HERIDA QUIRURGICA

EN BUSQUEDA DE DESCARTAR POSIBLES CAUSAS GRAVES DE DOLOR ABDOMINAL SE SOLICITAN PARACLÍNICOS.

SS: HEMOGRAMA, TIMEPOS DE COAGULACIÓN, ENZIMAS HEPÁTICAS BILIRRUBINAS, AMILASA, UROANALISIS, GRAM, CREATININA PRUEBA RÁPIDA DE ORINA DE EMABRAZO

SS: ECOGRAFÍA ABDOMINAL

06/02/2026

REVALORACIÓN CON RESULTADOS

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL

Se realizó ecografía de abdomen total utilizando transductor convexo multifocal y multifrecuencia, asociado a un sistema Doppler.

Estudio limitado técnicamente por dolor de elevada intensidad.

HALLAZGOS:

El hígado de morfología y topografía normal, impresiona de ecogenicidad homogénea.
No se observó dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática, el colédoco mide 3.6 mm.
La vesícula biliar distendida, de pared regular y fina, mide 1.8 mm, con contenido homogéneo.
El páncreas visible en cabeza, sin modificaciones significativas de la ecogenicidad, cuerpo y cola no valorables por abundante gas intestinal.
La aorta y vena cava dentro de límites normales en los segmentos evaluados.
El bazo de topografía y morfología normal, con ecogenicidad homogénea.
El riñón derecho de topografía, morfología y tamaño normal, la relación corticomedular está conservada, sin alteraciones pielocaliciales.
El riñón izquierdo de topografía, morfología y tamaño normal, la relación corticomedular está conservada, sin alteraciones pielocaliciales.
La vejiga moderadamente distendida, de paredes finas, con contenido homogéneo.
Se observa escasa cantidad de liquido hipoecoico a nivel perihepático, periesplénico, en correderas parietocólicas e hipogastrio.

CONCLUSIÓN:

• Escasa cantidad de líquido libre a nivel perihepático, periesplénico, en correderas parietocólicas e hipogastrio.

PRUEBAS HEPÁTICAS:
AST 12.4, ALT 18,3, BT 1,6, BD 0,3, BI 1.3 FA 119
PT 13.6(9.8) PTT 33.3 (27.6) INR 1.28
LDH 338.3
CREATININA 0.76,

AMILASA 284.6

UROANÁLISIS NO SUGESTIVO DE IVU, GRAM NO SE OBSERVAN BACTERIAS,

B HCG NEGATIVO, GRAVINDEX NEGATIVO

HEMOGRAMA
HEMATICO: HB 15 HCT 15.1
LEUCOCITARIO: WBC 3620 N 81.9% L 14.2%
PLAQUETAS 167.000,

EL GRUPO DE GINECOLOGICA ENCUENTRA PARACLÍNICOS ALTERADOS

SE SOSPECHA PANCREATITIS AGUDA

POR ELEVACIÓN DE AMILASA SE SOSPECHA PANCREATITIS

SE INTERCONSULTA CON CIRUGÍA GENERAL

06/02/2026

RESPUESTA INTERCONSULTA CIRUGÍA GENERAL

RESPUESTA

SE TRATA DE PACIENTE FEMENINA DE 31 AÑOS CON DOLOR POP , DE INTENSIDAD MODERADAA SEVERA, NOS INTERCONSULTAN POR REPORTE DE AMILASA ELEVADA Y SOISPECHA DE PANCREATITIS, LLAMA LAATENCION AMILASA EN LIMITE , PUEDE ESTAR EN RELACION A ANTECEDENTE QUIRURGICO, SE CONSIDERA ESTRATIFICAR, SE SOLICITAADICIONALMENTE LIPASA PARA MAYOR ESPECIFICIDAD Y SE REVALORARA CON TOMOGRAFIA YA SOLICITADA POR SERVICIO TRATANTE , DE MOMENTO SE AJUSTA MANEJO ANALGESICO, SE INDICA DNADA VIA ORAL DE MOMENTO

IDX
POP RESECCION QUISTE OVARICO POR LAPAROSCOPIA
DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO
- PANCREATITIS AGUDA NO BILIAR ????

EVOLUCIÓN GINECOLOGÍA 07-02-2026

TAC DE ABDOMEN Y PÉLVIS CONTRASTADA 7-2-2026

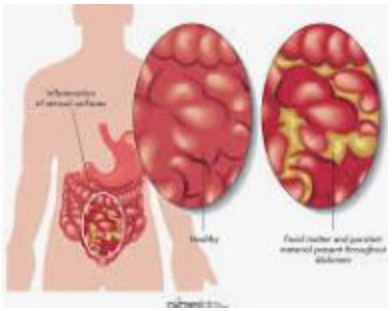
Hallazgos descritos sugiere Peritonitis.

Cambios inflamatorios de la grasa peritoneal en fosas iliacas y pelvis

Líquido libre en cavidad abdominal y pélvica en moderada cantidad.

Neumoperitoneo, correlacionar con tiempo de evento quirúrgico.

Páncreas de características tomográficas normal



GASES ARTERIALES CON ACIDOSIS METABOLICA COMPENSADA.

SE REALIZAN SCORE DE RIESGO DE PANCREATITIS Y SEPSIS→ NEGATIVOSS

ANTE LA IMAGEN Y CLÍNICA DE MALA EVOLUCIÓN → LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA URGENTES

SE DA MANEJO DE ABDOOMEN AGUDO.

SE DA ANTIBIOTICO PROFILACTICO.

PACIENTE DE 31 AÑOS CON DI9AGNSOTICOS
- DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO - ABDOMEN AGUDO
/PERINOTIS ABDOMINO/ PELVICAD DE ETIOLOGIA A DESCARTAR ** REPORTE TAC DE ADBOEMN CONTRASTADO 7/2/2026
/PANCREATITIS DE ORIGEN NO BILIAR ?? SOFA SCORE O PUNTOS / APACHE O PUTNOS
POP MEDIATO DE LAPAROSPIA DEL 5/2/2026 DE RESECCIO N DE QUISTE DE OVARIO ZIQUIEWRDO HALLAZGO INTRAOPERATORIO UTERO DE ASPECTO MACRO NORMAL CON ADHERENCIA DENSA DE FONDO UTERINO DENSA A PARED ABDOMINAL, CON RETRACCIÓN DE REPLIEGUE VSICO VAGINAL HACIA ADELANTE. QUISTE DE OVARIO IZQUIERDO CONTENIDO LIQUIDO TRANSPARENTE APROX 3 CM CON ADHERENCIA A LA TROMPA.-***

ANALSIS:

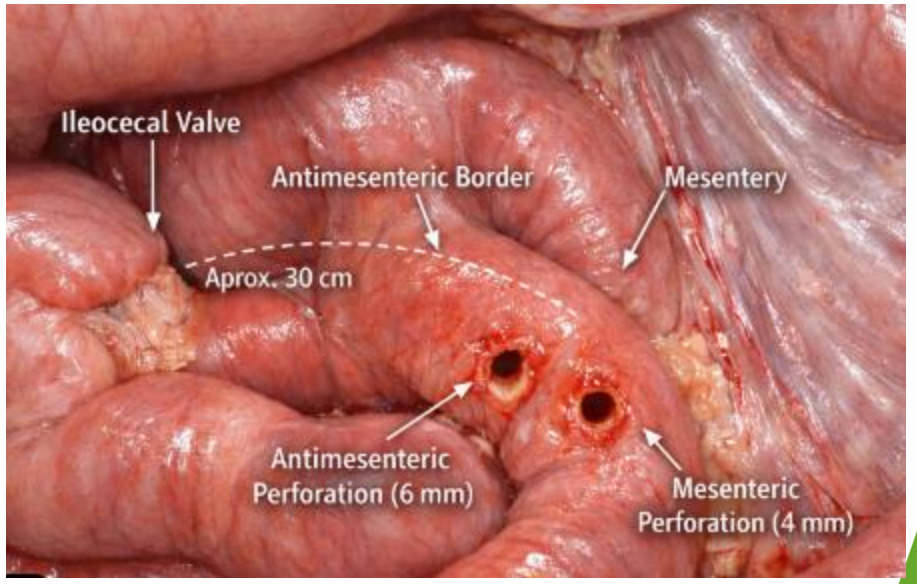
PACIENTE DE 31 AÑOS EN CONTESTRO DE POP' MEDIATRO DE RESECCION DE QUISTE IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA DEL 5/2/2026 CON HALLAZGO ADHERENCIA DENSA DE FONDO UTERINO DENSA A PARED ABDOMINAL HOSPITALAIZADA ENC OETXTO DE DOLRO ABDOMINAL EN ESTUDIO INTERROGADA UN PAROBABLE PANCREATITS DE ORINGE NO BILIAR, PRO RPESENTACION DE CUADRO CLINICO ??, SIN E,MABRGO EN EL MOMENTO PACIENTE CON PERSISTENCIA DE DOLRO ABDOMAINAL OINTOLERANCIA A LA VAI ORAL, ENE L MOEMNTO NO TQUCIARDICAS NROMOTENSA , ABDOEM DISTENDIDO CON DEFENSA MUSUCLAR DOLRO DIFUSO A LA PAPACION, DE PREDOMINIO EN HIPOGASTRIO Y EPIGASTRIO CONS IGNSO DE IRRITACION PERITONELA NO CLAROS GASES ARTERIALES CONTROLC ON ACIDOSIS METABOLICA COMPLESNADA LACTANTO EN DESCENSO CON RESPECTO AYER, SIN TRASNTORNO HIDROELECTROLITICO, HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS, SIN NEUTROFILIA, SIN ANEMIA, CON REPORTE OFICILA DE TAC CON SIGNSO DE PERITONITIS ABDIOMINAL Y PELVICA, COIN LIQUIDO LIBRE DE MODERADA CANTIDAD, SIN EMBARGO DE ETILOGIA NO CLARA, PACIENTE CON SOSPECHA ABDOEMN AGUDO SE IDNCIA LAPAROSCOPISA DIAGNOSITCA, SE INDICAC UBIRMIENTO ANTIBIOTICO PROFILACTICO, SE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REIFERE ENTENDER Y ACEPTAR

LLEVADA A QUIROFANO 07-02-2026

Descripcion de Hallazgos Operatorios, Procedimientos y Complicaciones

LAPAROSCOPIA:

SE REALIZA USO ADECUADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN EL CONTEXTO DE COVID-19. SE CONFIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO PREVIO POR PARTE DE LA PACIENTE.
PACIENTE COLOCADA EN DECÚBITO DORSAL. POSTERIORMENTE, SE LLEVA A CABO PROCESO DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE CAMPO QUIRÚRGICO, SE REALIZA CATETERISMO VESICAL Y SE COLOCAN CAMPOS ESTÉRILES.SE EFECTÚA INFILTRACIÓN CON ANESTÉSICO LOCAL A NIVEL UMBILICAL. SE PROCEDE AL INGRESO A LA CAVIDAD ABDOMINAL MEDIANTE LA TÉCNICA CERRADA, LOGRANDO CREAR NEUMOPERITONEO CONTROLADO, COLOCACION DE TROCAR DE 10 MM, POSTERIORMENTE CAMARA CON LENTE DE 30° VISUALIZACION DE ENTRADA SIN EVIDENCIA DE LESIONES ADVERTIDAS, PERO SE ENVIDENCIA ABUNDANTE LIQUIDO PERITONEAL EN CAVIDAD DE ASPECTO FECALOIDE, QUE LLEGA HASTA GOTERAS PARIETOCOLITAS, INSUFLACION DE CO2 HASTA 15 MM HG. INSERCION DE TROCAR DE 5 MM EN FOSA ILIACA IZQUIERDA BAJO VISION DIRECTA, SE RELIZA LAVADO DE CAVIDAD Y SE ASPIRA, SE



Descripcion de Hallazgos Operatorios, Procedimientos y Complicaciones

HALLAZGOS: PERITONITIS INTESTINAL GENERALIZADA, PERFORACION INADVERTIDA EN ILEON A 30-40 CM DE VALVULA ILEOCECAL EN ESPEJO ,BORDE ANTIMESENTERICO DE 6 MM Y EN BORDE LATERAL AL MESENTERIO DE 3-4 MM

DESCRIPCION QX
LLAMADO INTRAOPERATORIO DE GINECOLOGIA, PACIENTE CON TROCAR UMBILICAL DE 12 MM ,SE

UTILIZAN PUERTOS ANTERIORES, DE 5 MM LATERAL Y SE CONVIERTE EL INTERMEDIO A 12 MM ,SE REALIZA DRENAJE DE LIQUIDO PERITONEAL, SE REALIZA ENTERORRAFIA ANTERIOR CON V-LOK PUNTO DE GAMBEE, SE REALIZA ENTERORRAFIA EN SEGUNDO PLANO CON VICRYL PERFORANTE TOTAL, ENTERORRAFIA #2 CON VICRYL PUNTO EN X E INVAGINANTE CON VICRYL 3-0 , SE REALIZA LAVADO SISTEMATICO DE CAVIDAD ABDOMINAL Y ASPIRADO DE LIQUIDO LIBRE EN CUATRO CUADRANTES, RETIRO DE MEMBRANAS , LAVADO PERITONEAL CON SSN ESTERIL HASTA RETORNO CLARO, SE UBICA DRENAJES DE JACKSON PRATT, LATERAL E INFERIOR EN PELVIS Y ADYACENTE A ENTERORRAFIA Y SUPERIOR EN GOTERA PARIETO COLICA IZQUIERDA, SE FIJA CON SEDA , SE CIERRA FASCIA DE PUERTOS DE 12 MM CON VICRYL 1-0, PIEL CON P´ROLENE 3-0 , SE FINALIZA PROCEDIMIENTO EN CONJUNTO CON SERVICIO DE GINECOLOGIA

- Se hace enterorrafia, lavado y se dejan drenajes Jackson Pratt



EVOLUCIÓN CLINICA 08-09-10/02/2026

POSTOPERATORIO LAVADO PERITONEAL + ENTRORRAFIA POR VIA PERITONEAL 07/02/2026. AL MOMENTO DE LA VALORAICON PACIENTE ALERTA, ORIENTADA, CON SONDA NASOGASTRICA A LIBRE DRENAJE DE 400 CC ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE CON PRESENCIA DE DRENES DE JACKSON PRATT DERECHOS, SUPERIOR CON DRENAJE DE 25 CC EN 12 HORAS E INFERIOR DE 30 CC EN 12 HORAS, PAICNETE QUIEN REFIERE ADECUADA MODULACION DEL DOLOR ABDOMINAL, EN CUBRIMIENTO ANTIBIOTICO CON AMPICILINA SULBACTAM Y METRONIDAZOL HOY DIA 1, CUENTA CON HEMOGRAMA SIN ALTERACION EN SUS LINEAS CELULARES, PACIENTE CON EVOLUCION LENTA HACIA LA MEJORIA, SEGUN ESTA SE DEFINIRAN CONDUCTAS ADICIONALES, SIN CAMBIOS EN MANEJO MEDICO, SE LE EXPLICA A PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

08-02 ADECUADA EVOLUCIÓN

PARACLINICOS

08/02/2026: CREA 0.71 BUN 7.1 LDH 299.6 BT 0.4 BD 0.1 BI 0.30 HEMOGRAMA LEU 5.35 NEU 91.9 LINMF 2.9 HB 11.7 HCTO 35.7 PLQ 126
07/02/2026: HEMOGRAMA LEU 5.46 NEU 89 LINF 7.7 HB 13.8 HCTO 42.4 PLQ 144
06/02/2026:
K 4.2 NA 140.9 CL 111.5
BUN 7.1 NA 141.4 CL 110.8 K 4.02 FA 119.0 AMILASA 284.6
PT 13.6 INR 1.283 PTT 33.3 ALT 12.4 AST 18.3 BT 1.6 BD 0.3 BI 1.30 LDH 338.3 CREATININA 0.76 GRAM NEGATIVO
UROANALISIS NO PATOLOGICO HEMOGRAMA LEU 3.62 NEU 81.9 LINF 14.2 HB 15.0 HCTO 45.1 PLQ 167

SE ABRE FOLIO PARA REPORTE DE CULTIVO DE LÍQUIDO PERITONEAL.

SERRATIA MARCESCENS
SENSIBLE A : AMICACINA, CEFEPIA, CIPROFLOXACINO, ERTAPENEM, LEVOFLOXACINA, MEROPENEM, TIGECICLINA, T/Z

09-02 REPORTE DE CULTIVO

PACIENTE DE 31 AÑOS CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS EN SEGUIMIENTO DE SU POP REFIERE CUADRO CLÍNICO SE NAUSEAS, DEPOSICIONES LIQUIDAS Y DOLOR ABDOMINAL TIPO COLICO, CON SIGNOS VITALES TA 120/75 FC 95 FR 19 SAO2 95 % CONCIENTE, ORIENTADA CARDIOPULMONAR NORMAL, ABDOMEN BALNDO DEPREISBLE DOLOROS EN HIPOGASTRIO HERIDAD QUIRIRDICAS SIN ESTIGMA DE SANGRADO DREN EN HEMIABDOMEN IZUQIERDO CON ESCASO DRENAJE EXTREMIDADES NO EDEMAS NEUROLÓGICO SIN DÉFICIT

ESCALA DE DOLOR 3/10

DADO CUADRO CLINICO SE INDICA DOSIS DE ANTIESPASMODICO SE AJSUTA ANAÑLEGSIA A INTRAVENOSOS SE EXPLICA MANEJO CONTINAU VIGILANCIA CLINCIA INSTAURADA.

10-02-2026

CIPROFLOXACINA

EVOLUCIÓN CLINICA 11/02/2026

CATERINE ARANGO, PACIENTE FEMENINA DE 31 AÑOS DE EDAD, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE POSTOPERATORIO DE LAVADO PERITONEAL MÁS ENTERORRAFIA POR VÍA LAPAROSCÓPICA REALIZADOS EL 07/02/2026. A LA VALORACIÓN HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, SIN SIGNOS DE ABDOMEN AGUDO, CON MEJORÍA DE CUADRO DIARREICO, SIN NUEVOS EPISODIOS EMÉTICOS, TOLERANDO VÍA ORAL, EN MANEJO ANTIBIÓTICO OPTIMIZADO POR RESULTADO DE CULTIVO PERITONEAL, CON HEMOGRAMA DE CONTROL CON LEVE LEUCOCITOSIS, Y NEUTROFILIA, SIN ANEMIA, CON DRENES FUNCIONALES, HERIDAS QUIRÚRGICAS SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, CON POTASIO FUERA DE METAS POR LO QUE SE PIDE VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA Y SE INICIA REPOSICIÓN ORAL, POR EL MOMENTO SEGUIMOS EVOLUCION CLÍNICA, DEL RESTO DE MANEJO IGUAL. SE EXPLICA AL PACIENTE Y REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

11/02/2026: NA 141.9 K 2.38 CL 101.5 CREA 0.81 HEMOGRAMA LEU 11.71 NEU 90.2 LINF 5.9 HB 12.6 HCTO 37.1 PLQ 164

RESPUESTA – MEDICINA INTERNA

- INICIAR REPOSICIÓN DE POTASIO ENDOVENOSA
- DIFÍCIL ACCESO --> CATÉTER CENTRAL PERIFERICO
- INICIO DE SULFATO DE MAGNESIO
- SE SUSPENDE MANEJO DE DIURETICO

PARACLINICOS

12/02/2026 SODIO 139.3, POTASIO 3.63, CLORO 105.6, CREATININA 0.61, HEMOGRAMA WBC 12150 N 91.6% HB 11.3 HCT 33.4 PLAQUETAS 163.000

EVOLUCIÓN CLINICA 12/02/2026

ANALISIS

CATERINE ARANGO, PACIENTE FEMENINA DE 31 AÑOS DE EDAD, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE POSTOPERATORIO DE LAVADO PERITONEAL MÁS ENTERORRAFIA POR VÍA LAPAROSCÓPICA REALIZADOS EL 07/02/2026. A LA VALORACIÓN HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE, SIN SIGNOS DE BAJO GASTO, SIN IRRITACION PERITONAL, ABDOMEN LEVEMENTE DISTENDIDO, DOLOR A LA PALPACION SUPERFICIAL, CON POCA TOLERANCIAA VÍA ORAL, EN MANEJO ANTIBIÓTICO OPTIMIZADO POR RESULTADO DE CULTIVO PERITONEAL, CON HEMOGRAMA DE CONTROL CON AUMENTO DE LEUCOCITOS, Y NEUTROFILIA, SIN ANEMIA, CON DRENES DE JACKSON PRATT FUNCIONALES CON DRNAJE DE 30 CC, HERIDAS QUIRÚRGICAS SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, PACIENTE VALORADA POR EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA QUIENES AJUSTARON MEDICACION PARA TRASTORNO ELECTROLITICO HOY CON POTASIO EN METAS, PENDIENTE ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA DETERMINAR POSIBLE COLECCION PERITONEAL, POR EL MOMENTO SEGUIMOS EVOLUCION CLÍNICA, DEL RESTO DE MANEJO IGUAL. SE EXPLICAAL PACIENTE Y REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

- AUMENTO DE LEUCOCITOS Y NEUTROFILIA
- DRENES JACKSON PRATT 30 CC
- P// ECOGRAFIA ABDOMNE --> POSIBLE COLECCION PERITONEAL

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL

Se realizó ecografía de abdomen total utilizando transductor convexo multifocal y multifrecuencia, asociado a un sistema Doppler

HALLAZGOS:

El hígado de morfología y topografía normal, de ecogenicidad homogénea.
No se observó dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática.
La vesícula biliar distendida, de pared regular y fina, mide 1.3 mm, con contenido homogéneo.
El páncreas visible en cabeza y cuerpo, sin modificaciones significativas de la ecogenicidad, cola no valorable por gas intestinal.
La aorta y vena cava dentro de límites normales en los segmentos evaluados.
El bazo de topografía y morfología normal, con ecogenicidad homogénea.
El riñón derecho de topografía, morfología y tamaño normal, la relación corticomedular está conservada, sin alteraciones pielocaliciales.
El riñón izquierdo de topografía, morfología y tamaño normal, la relación corticomedular está conservada, sin alteraciones pielocaliciales.
La vejiga poco distendida, con contenido homogéneo.
Se observa escasa cantidad de líquido anecoico a nivel perihepático y en hipogastrio.

CONCLUSIÓN:

• Escasa cantidad de líquido libre a nivel perihepático e hipogastrio.

13/02/2026

EVOLUCIÓN CLINICA 13-14/02/2026

ANALSIS:

PACIENTE DE 31 AÑOS CON ANTECEDENTE DE LAPAROSOCOPIA EXPLORATORIA CON HALLAZGO DE LESION INTESTINAL INADVERTIDA CORREGIDA POR CX GENERAL EN MANEJO DE INFECCIÓN PERITONEAL CON RESCATE DE SERRATIA MARCESCENS PATRÓN AMPC HOY DIA 3 DE MANEJO CON CIPROFLOXACINA , HOY CON POTASIO EN 3.11 YA SE INICO NUEVAMENTE REPOSICION , SE RECIBE REPORTE DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL CON ESCASO LIBRE PEROHEPATICO ESPERADO PARA SU POP ; EN EL MOMENTO SIN SIGNOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTEMICA SIN FIEBRE , SIN NUEVOS EPISODIOS DE EMESIS CON TOLERANCIA DE LA VIA ORAL , PRESENTA HOY MEJOR CONTROL DEL DOLOR CON DRENES CON ESCASO DRENAJE EN PLAN DE RETIRO DE LOS MISMOS POR PARTE DE CX GENERAL , SE INDICA CONTUNAR CON MANEJO DESCRITO Y REPOSICION DE ELECTROLITOS ; POR GINECOLOGIA CONTINUAMOS COMO SERVICIO ACOMPAÑANTE

PARACLINICOS

13/02/2026 CH LEUCO 11.59 N 89.1 LINF 8.7 HB 10.7 HCTO 31.7 PLT 176.0 CREAT 0.53 CL 102.3 K 3.11 NA 139



14/02/2026

AYER POR PARTE DE CIRUGIA RETIRAN DRENES ABDOMINAL, SE COMENTA PACIENTE CON CIRUJANO DE TURNO DR MONSALVE Y SE CONSILIA ANALGESIA CON BUSCAPINA COMPUESTA ANTIEMETICO Y SOLICITAR TAC DE ABDOMINA CON DOBLE CONTRANSTE PARA DEFINIR CONDUCTA SE INICIA TERAPIA FISICA, POR GINECOLOGIA CONTINUAMOS COMO SERVICIO ACOMPAÑANTE

PARACLINICOS

14/2/26 POTASIO 3.74

- CON REPOSICIÓN DE POTASIO EN 3.74
- ABDOMEN DISTENDIDO – DOLOROSO – EPISODIO DE EMESIS
- CONSILIACION ANALGESICA
- SOLICITUD DE TOMOGRAFIA

TOMOGRAFÍA CONTRASTADA ABDOMINAL 14/02/2026

IMAGENOLOGIA

14/02/2026: TAC DE ABDOMEN: DERRAMES PLEURALES LAMINARES BILATERALES, QUE CONDICIONAN ATELECTASIAS PASIVAS PARCIALES DEL PARÉNQUIMA PULMONAR SUBYACENTE DEL HÍGADO ES DE LOCALIZACIÓN, TAMAÑO, CONTORNOS Y DENSIDAD NORMALES. LA VESÍCULA BILIAR SE ENCUENTRA DISTENDIDA, CON PAREDES DELGADAS Y CONTENIDO HOMOGÉNEO. LA VÍA BILIAR INTRA Y EXTRAHEPÁTICA ES DE CURSO Y CALIBRE NORMAL. EL PÁNCREAS, EL BAZO Y LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES TIENEN ASPECTO ESCANOGRÁFICO NORMAL. LOS RIÑONES CONCENTRAN DE FORMA HOMOGÉNEA Y SIMÉTRICA EL MEDIO DE CONTRASTE. CÁMARA GÁSTRICA SOBREDISTENDIDA. DILATACIÓN DE ASAS INTESTINALES DELGADAS DE HASTA 38 MM Y SIN IDENTIFICAR ZONA DE TRANSICIÓN.

REALCE LISO DEL PERITONEO. ESCASA CANTIDAD LÍQUIDO LIBRE EN AMBAS GOTERAS PARIETOCÓLICAS Y ESCASA CANTIDAD LÍQUIDO COMPARTÍMENTALIZADO DE LA PELVIS. COLECCIÓN EN EL ESPACIO RECTOVESICAL DE 61 × 20 × 40 MM, VOLUMEN APROXIMADO DE 25 CC. LAS ESTRUCTURAS VASCULARES RETROPERITONEALES SON DE CURSO Y CALIBRE NORMAL. NO HAY ADENOMEGALIAS EN CAVIDAD ABDOMINAL. ÚTERO DE ASPECTO NORMAL. VEJIGA

DISTENDIDA, DE PAREDES DELGADAS Y CONTENIDO HOMOGÉNEO.

OPINIÓN:

DERRAMES PLEURALES LAMINARES BILATERALES, QUE CONDICIONAN ATELECTASIAS PASIVAS PARCIALES DEL PARÉNQUIMA PULMONAR SUBYACENTE.

CÁMARA GÁSTRICA SOBREDISTENDIDA Y DILATACIÓN DE ASAS INTESTINALES DELGADAS DE HASTA 38 MM Y SIN IDENTIFICAR ZONAS DE TRANSICIÓN, HALLAZGOS SUGESTIVOS DE ILEO ADINÁMICO, CORRELACIONAR CON CLÍNICA

REALCE LISO DEL PERITONEO EN PELVIS SUGESTIVO DE PERITONITIS.

ESCASA CANTIDAD LÍQUIDO LIBRE EN AMBAS GOTERAS PARIETOCÓLICAS Y ESCASA CANTIDAD LÍQUIDO COMPARTÍMENTALIZADO DE LA PELVIS.

COLECCIÓN EN EL ESPACIO RECTOVESICAL DE 61 × 20 × 40 MM, VOLUMEN APROXIMADO DE 25 CC.

- CAMARA GÁSTRICA SOBREDISTENDIDA
- DILATACIÓN DE ASAS INTESTINALES SIN IDENTIFICAR ZONA DE TRANSICIÓN
- ESCASO LIQUIDO EN GOTERAS PARIETOCOLICAS
- COLECCIÓN EN EL ESPACIO RETROVESICAL 25 CC

INFORME QUIRÚRGICO 15/02/2026

TIPO DE HERIDA:

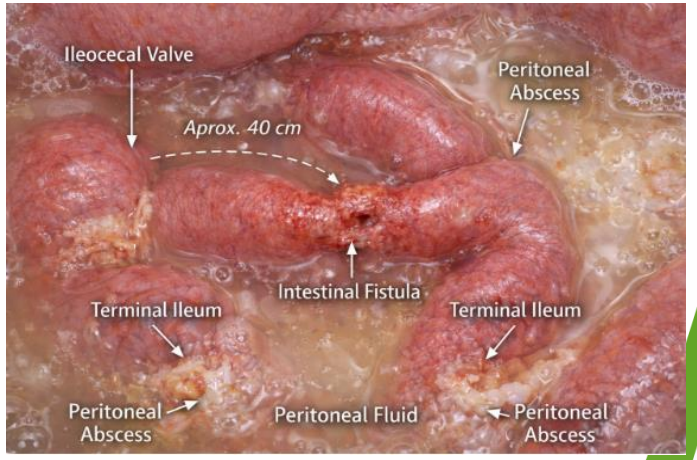
Contaminada

Descripcion de Hallazgos Operatorios, Procedimientos y Complicaciones

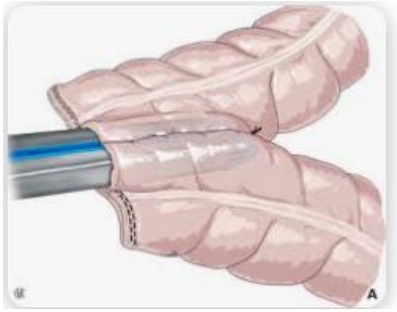
HALLAZGOS PERITONITIS PURULENTA DE LOS CUATRO CUADRANTES, FISTULA INTESTINAL EN ILEON TERMINAL A 40 CM DE LA VALCULO ILEOCACAL, CON ADHERENCIAS LAXAS, PERIAPENDICITIS

BAJO ANESTESIA , PAA , INCISION MEDIANA SUPRA E INFRAUMBILICAL, DISECCION POR PLANOS HASTA EL PERITONEO, SE TOMA MUESTRA DE ABSCESO PERITONEAL PURULENTO, SE DRENA PERITONITIS PURULENTA DE LOS CUATRO CUADRANTES ABDOMINALES, SE REALIZA LAVADO PERITONEAL CON 4500 CC DE SSN, SE ASPIRAN LOS EXUDADOS, SE REALIZA RESECCION DE 40 CM DE ILEON A 40 CM DE LA VALVULA ILEOCECAL, SE REALIZA ANASTOMOSIS TERMINO TERMINAL DEL INTESTINO DELGADO CON MONOFILAMENTO 4-0 TENICA DE SUTURA CONTINUA DE DOS PILARES, SE REALIZA SUTURA DEL DEFETO DEL MESO INTESTINAL CON MONOFLAMENTO 4-0, SE REALIZA APENDICECTOMIA SE PINZA Y LIGA EL MESO Y LA BASE APENDICULAR CN SEDA 0, SE VERIFICA Y CORRIGE LA HEMOSTASIA, SE DEJA DREN POR

CONTRABERTURA EN FLANCO IZQUIERDO TIPO JACKSON PRATT Y SE FIJA CON MONOFILAMENTO 2-0, POR EL ALTO GRADO DE CONTAMINACION DEL PERITONEO SE INDICA CIERRE DE ABDOMEN CON BOLSA DE BOGOTA, INTRAPERITONEAL Y SUTURA DE PIEL CON MONOFILAMENTO 2-0, SE ORDENA PROXIMO LAVADO EN 48 HORAS.



- PERITONITIS PURULENTA 4 CUADRANTES
- FISTULA INTESTINAL EN ILEON TERMINAL
- SE TOMA MUESTRA DE ABCESO PERITONEAL
- RESECCION DE 40 CM DE ILELON
- ANASTOMISIS
- APENDICECTOMIA
- DREN JACKSON
- BOLSA BOGOTA



EVOLUCIÓN 16-02-2026

ANALSIS:

PACIENTE DE 31 AÑOS, HOSPITALIZADA EN CONTEXTO DE POP DE LAPARATOMIA EXPLORATORIA CON EVIDENCIA DE PERITONITIS GENERALIZADA DE CUATRO CUADRANTES, CON REQUERIMEINTO DE RESECCION INTESTINAL Y ANASTOMOISIS TERMINOTERMINA, DRENAJE DE COLECCION , LAVADO PERITONEAL Y APENDICECTOMIA DIA 1, CON BOLSA BOGOTA, POR SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL, CON ANETCEDENTE DE RESECCION DE QUISTE DE OVARIO POR LAPAROSCOPIA Y POP DE LAVADO PERITONEAL POR VÍA LAPAROSCÓPICA + ENTERORRAFIA POR LESION INAVERTIDA DE ANTECEDENTE QUIRURGICO DEL DIA 05/02/2026, REFIERE SENTIIRSE MEJOR, DOLOR MODULADO, SIN NUEGOS EPISODIOSD E EMESIS, EN EL MOMENTO REGULARES CONDICIONES GENERALES, CON TENDENCIAA TAQUICARDIA, TAM EN METAS, SIN OXIGENO SUPLEMENTARIO, SIN DISTENSION DE ABDOPMEN, NO ABDPOMEN QUIRURGIUCOI, HERIDA QUIRRUGICA CUBIERTA CON APOSITO, SODA NASOGASTRICA PERMEABLE, DREN DJACKSON FUNCIONAL CON ESCASO MATERIAL SEROHEMATICO, ADEUCADO GASTO URINARIO, SIN PERDIDAS VGINALES. PACIENTE EN MANEJO POR CIRUGIA GENERAL, EN CUBRIMIENTO ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO CON PIPERACILINA + TAZOBACTAM DIA 1, SERVICIO DE GINECOLOGIA COMO SERVICIO ACOMPAÑANTE. SE ESPERARAA SEGUNDO TIEPMPO QUIREURGICO POR PARTE DE CIRUGIA GEENRAL., EN ESPERA DE AISLAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS. SE ENCUENTRA RECIBIENDO NUTRICIÓN, PARENTERAL. CONTINUA MANEJO POR CX GENERALK CONTINUARMOS ACOMPAÑAMIENTO. SEEXPLICAA LA PACIENTE QUIEN ENTIENDE Y ACEPTA.



- PIPERACILINA – TAZOBACTAM DIA 2
- PENDIENTE REVISIÓN QUIRURGICA

Gracias

HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E

Crecemos para cuidar tu Salud!

ANA MARITZA DÁVILA BARÓN

GERENTE